

25 - Tuberculose génitale de la femme (Audio) - Pr. HAROU

Alors, la tuberculose génitale, comme son nom l'indique, c'est comme toutes les tuberculoses que vous avez étudiées dans les hausses matières. On continue à enseigner la tuberculose au Maroc parce qu'on sait que le Maroc est un pays endémique, qu'on n'a pas réussi à éradiquer totalement la tuberculose, donc on continue à l'enseigner en vue que les médecins fassent un diagnostic et ne pas laisser les patients traîner pendant des années. On sait que la tuberculose génitale peut entraîner un problème grave chez la femme, qui est l'infertilité.

Il y a beaucoup de femmes qui deviennent infertiles parce qu'elles ont une tuberculose au cours de leur enfance, au cours de leur début de vie génitale, elles ont une tuberculose qui a fait détruire leur capital, notamment l'endométrie, on va le voir, elle touche l'endomètre, elle touche les trompes, elle détruit les trompes, et parfois la destruction est irréversible, ce qui fait qu'elles vont être infertiles et on va voir que les propositions thérapeutiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de santé publique, il s'agit essentiellement du *Mycobacterium tuberculosis*, et aujourd'hui cette tuberculose va masquer et va se présenter sur plusieurs formes, plusieurs tableaux, et donc parfois des tableaux pour trompeurs, parce qu'elle va plus mimer une masse génitale, masse ovarienne, en cas de tuberculose annexielle, elle va mimer des symptômes tels que l'hémorragie post-ménopausique lorsqu'il y a des femmes ménopausées, etc, donc la clinique n'est pas spécifique. Donc, heureusement que cette tuberculose génitale n'est pas aussi fréquente que ça, on voit qu'on parle de tuberculose urogénitale, parce que si elle touche l'appareil urinaire, elle peut toucher l'appareil génital et vice-versa, et que la génitale représente la moitié de cette tuberculose urogénitale qui, elle, représente 0,5% des tuberculoses extrapulmonaires, ce qui est quand même assez rare, donc ce n'est pas quelque chose à qui penser tout le temps, donc les agents pathogènes, c'est le *Mycobacterium*, qui soit *tuberculosis* le plus souvent en bovis, donc le mode de transmission est un peu bizarre parce qu'il est essentiellement respiratoire, toujours le départ, c'est une tuberculose pulmonaire, par la suite, il faut toujours demander à la patiente, elles ont fait une tuberculose pulmonaire, probablement diagnostiquée ou maltraitée, guérie avec des séquelles, et par voie, on va le voir, par voie hématogène le plus souvent, cette tuberculose va se retrouver dans d'autres organes, dans les ganglions, dans l'os, et aussi dans l'appareil génital ou l'appareil urinaire.

Exceptionnellement, on peut avoir des atteintes primaires, *tuberculosis primitif*, qui dans la voie sexuelle est incriminé, mais le plus souvent, je vous ai dit, c'est secondaire, donc qui dit secondaire, lorsqu'on diagnostique une tuberculose génitale, il faut rechercher une tuberculose pulmonaire, d'accord ? Parce que le traitement ne peut pas être la même chose, la durée du traitement n'est pas la même, vous avez étudié la tuberculose d'ensemble, on vous a séparé la tuberculose pulmonaire de la tuberculose extra-pulmonaire, les extra-pulmonaires c'est un chapitre, les pulmonaires c'est un chapitre, c'est pas le même protocole, c'est pas la même durée de traitement. On traite les tuberculoses où ? Dans les centres régionaux ? Oui ? Est-ce que

vous êtes passé dans les services de maladies infectieuses ? On traite la tuberculose d'empement ? La pulmonaire, des cas hospitalisés parce qu'on voulait faire le diagnostic, on voit le diagnostic il est fait, hein ? Qui donne le traitement ? Le service d'empement ? C'est pas le service d'empement, est-ce que le service d'empement possède les traitements ? Pourquoi ? Tout à fait, les centres de lutte anti-tuberculeux qui sont des centres de santé mais spécialisés dans la tuberculose. Pourquoi à votre avis ? Tout à fait, pour éviter que tout le monde puisse traiter cette tuberculose à tort et à travers, qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des problèmes.

Il faut faire très attention, il y a des médecins qui n'ont pas fait leur formation en Maroc, ils ont fait leur formation ailleurs, ils ne savent pas qu'il y a un circuit de santé publique dédié pour la tuberculose. Donc ils se retrouvent en train de traiter une tuberculose de fluoroquinolone pendant des mois et des mois, avec des catastrophes par la suite. J'ai vu récemment une patiente traitée par un médecin qui a fait ses études en Espagne.

Il l'a fait comme en Espagne, il l'a traité avec du fluoroquinolone, la patiente a fait une résistance, un truc carabiné. Donc il faut faire attention. Et normalement c'est médico-légal.

Ce médecin-là risque une poursuite judiciaire. Ce n'est pas respecté. Quand vous êtes dans un pays, il faut respecter le cadre légal de ce pays.

Il y a des maladies à déclaration obligatoire. On vous a enseigné les maladies à déclaration obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, il y a une obligation.

C'est-à-dire que si vous ne le faites pas et que vous vous coincez, vous êtes dans... Donc il faut faire attention. Parce que là vous êtes étudiant, mais après quand vous aurez un diplôme, vous ne serez pas excusé. Il y a la tuberculose, c'est une maladie à déclaration obligatoire.

Vous ne pouvez pas, en général vous n'allez pas la déclarer au ministère, mais le fait de l'envoyer au centre, c'est déjà une déclaration, c'est eux qui vont la déclarer. Vous êtes dans l'obligation de l'envoyer au centre. Et de vérifier par la suite est-ce qu'elle est partie.

Parce que vous pouvez l'envoyer au centre, elle va chercher une thérapeutique ailleurs. Donc attention. Alors la tuberculose, le diagnostic, on va vous parler de génexperts, etc.

Mais bon, la tuberculose génitale, le diagnostic, le gold standard reste l'histologie. L'histologie avec le fameux granulome, la ptélogie gantocellulaire avec nécrose caseuse. Mais malheureusement, pas toujours on trouve cet aspect histologique et parfois on peut être dans l'embarras.

Donc finalement on peut se fier à un certain nombre d'arguments cliniques, biologiques, histologiques pour faire le diagnostic. Mais déjà on peut reconnaître cette tuberculose lorsqu'on fait par exemple une intervention chirurgicale pour infertilité, une celluloscopie pour infertilité, être amené à avoir des trempes un peu bizarres qui peuvent nous évoquer le diagnostic. Parce que la

patiente ne va pas venir vous dire j'ai tuberculose tuber.

Donc lorsque vous faites un bilan, vous allez trouver soit un aspect de ce qu'on appelle les endosalpingites ou les exosalpingites. Les exosalpingites c'est beaucoup plus facile parce que vous avez des trempes avec des tubercules. Mais les endosalpingites c'est plus difficile parce que vous n'allez pas voir, c'est vraiment une atteinte interne.

L'endomètre lui en général quand il y a une tuberculose génitale c'est une fois sur deux qu'il est atteint. Mais on peut avoir des localisations autres telles que le col, le vagin, la vulve. La vulve ça va être plus de la tuberculose cutanée.

Et cette tuberculose va toujours se manifester sous forme de petits nodules, des granules jaunâtres, aplanchâtres, qui peuvent aller de 0,5 à 2 mm. Donc on distingue, ça c'est des formes granulaires. Vous avez les formes avec des ulcères et du caseum, ce qu'on appelle les formes ulcéro-caseuses.

Vous avez des formes avec des adhérences, dites fibro-adhésives. Et des formes où vous aurez un tableau de granules avec de l'acide qui peut parfois mimer ce qu'on appelle une carcinose péretoniale. C'est comme de la carcinose péretoniale, ça ressemble vraiment à la carcinose péretoniale, sauf que c'est de la tuberculose.

Mais la microscopie, comme vous dites, c'est un granulome épithéliogégondocédaleur avec nécrose caseuse, c'est pour le diagnostic de... Voilà, ça c'est à peu près l'aspect qu'on peut retrouver, avec un aspect, regardez, des trempeaux dînés, avec des rétrécissements étagés sur la trempe, comme vous voyez ça, avec des agglutinations des franges, comme vous voyez ça, c'est typiquement une tuberculose. C'est la millière dont je vous ai parlé, la millière tuberculose, vous voyez des petits grains blanchâtres à jaunâtres sur le turus, vous voyez, sans masse ovarienne, là il n'y a pas de masse ovarienne. Lorsqu'il y a une masse ovarienne, avec ça, on va penser plus à une carcinose péritonelle avec un cancer de l'ovaire.

Et là, regardez l'aspect ici d'une endosalpingite, ça veut dire que l'atteinte est interne, et l'atteinte extérieure on l'appelle une exosalpingite. Et puis, c'est très rare qu'on va retrouver une tuberculose génitale sans qu'il y ait une atteinte diffuse, péritonelle, avec des adhérences, avec des granulations, on peut aller en région soudiaphragmatique avec des adhérences péri-hépatodiaphragmatiques, ça vous rappelle le syndrome de Fuchs-Hugues-Curtis, c'est un syndrome post-infectieux, mais dû au chlamydien. Mais là, on va voir des granules avec.

La différence entre les deux, c'est que l'atteinte chlamydienne c'est surtout des visicules, avec des adhérences, bien sûr, et l'atteinte tuberculose, il y a des adhérences mais avec des granules. Donc ça c'est sur le plan ostéologique que ça représente un granulome épithéologique en tout celui-là avec une crosse caséuse. Maintenant, comme je vous ai dit, le diagnostic histologique est parfois rare.

Vous avez compris qu'il faut faire des biopsies pour avoir le diagnostic histologique, que ce soit sur la trompe ou sur l'endomètre. Parfois pas toujours facile, parce que la tuberculose va entraîner une destruction des tissus, donc l'endomètre, par exemple, il va être vraiment détruit et parfois vous n'allez rien retrouver. Il n'y a même pas de tissu à biopsie tellement c'est adhésif et ça peut entraîner, on va voir ce qu'on appelle une synéchie complète, appelé classiquement le syndrome, vous l'appellez ça ? Syndrome d'Achermann.

Syndrome d'Achermann est un syndrome consistant à une synéchie totale, le plus souvent pour la tuberculose. Mais sur le plan clinique, il y a des signes qui vont nous orienter, les signes généraux, typiques, l'asténie, l'hécatrisme, l'hygrisme, l'orexie, une fièvre surtout nocturne persistante, des sueurs nocturnes. Puis vous avez des signes fonctionnels qui peuvent amener la patiente à consulter telle quelle douleur est en général due aux adhérences.

Elles sont en général peu intenses et chroniques, mais la fertilité reste le maître symptôme et le motif le plus fréquent de consultation, c'est l'infertilité. On peut avoir des troubles du cycle, surtout si la tuberculose est survenue à un âge très précoce avec carrément une aménorrhée, une destruction de l'endomètre entraînant une aménorrhée, donc plus de règles, ce qu'on appelle les aménorrhées primaires. On peut avoir des dysménorrhées, on peut avoir des ménométroragies, on peut avoir des tableaux abdominaux avec des ballonnements, des masses, de l'acide et parfois on peut avoir des locorées rebelles aux traitements médicaux, un endomètre qui est infecté, qui ne répond pas aux antibiotiques habituelles.

On va toujours essayer de faire un examen complet de la vulve jusqu'à l'utérus, chercher une anomalie des lèvres, notamment une hypertrophie, des ulcérations génitales, rechercher s'il y a une masse au niveau du col, une masse latérale utérine fixée, ça peut être un kyste ovarien, et toujours rechercher la notion d'acide. Alors l'échographie c'est toujours l'examen de première attention en gynécologie, quels que soient les symptômes, douleurs péloviennes, dysménorrhées, masse aménorrhée, on va faire l'échographie. L'échographie va pouvoir nous apporter beaucoup de choses, d'essayer de la citer, on peut la visualiser à l'échographie, on peut avoir l'épaisseur de l'endomètre, on peut voir une masse annexielle si elle est existante, une masse de l'annexe en cas de tuberculose annexielle, donc cette échographie pourra beaucoup nous apporter, mais parfois cette tuberculose va être découverte sur un examen classique de l'infertilité, vous savez que la fertilité c'est obtenir une patiente infertile, l'échographie, mais il y a l'hystérosalpingographie parce qu'on cherche toujours à voir les trompes, et parfois cette hystérosalpingographie va nous donner des aspects typiques de tuberculose, avec une bonne sensibilité, on peut avoir des contours irréguliers comme vous voyez sur la photo en haut, avec des images d'addition, on peut avoir des fistules carrément, on peut avoir des obstructions en tube, donnant un aspect d'hydrosalpinx, comme c'est le cas ici, vous voyez deux grosses hydrosalpinx avec un effacement carrément de la muqueuse tube, ou bien on peut avoir ce qu'on appelle un aspect en chapelet, avec de multiples sténoses que vous voyez ici, petites sténoses, une à côté de l'autre, et en général même en voyant ces images là, on peut déjà faire

du pronostic, quand vous n'avez plus de plis tuber, pronostic il est mauvais, quand vous avez des sténoses comme ça avec des fistules, le pronostic il est mauvais, plus souvent le pronostic il est mauvais, parce que la tuberculose elle est très destructrice de la muqueuse tuber, elle va entraîner des séquelles, parfois le plus souvent, pas parfois, le plus souvent irréversible.

D'autres aspects, plus graves, ça c'est quoi ? Qu'est-ce qui est pacifié ? Le vagin, il n'y a même pas de pacification du thyroïde, c'est ce que je vous ai parlé du syndrome, au sein desquels les petites cynichies donnent témoignent d'une grande destruction de la troupe. Ici vous voyez des lacunes à l'emporte-pièce, un rétrécissement de la cavité témoignant d'une cynichie, ici des petites cynichies à l'emporte-pièce. Alors, la différence entre celle-là et celle-là, quelle est celle de meilleur pronostic ? Il y a une cavité, ici il n'y a presque pas de cavité, la cavité c'est une cavité dite en T, ici il y a une cavité, il y a des cynichies, on sait qu'ici on va pouvoir libérer les adhérences et pouvoir avoir une cavité normale.

Alors que là, même si on rentre dans l'utérus, on sait qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Parfois, comme je vous ai dit, la tuberculose est découverte lors d'un bilan sélioscopique. Une sélioscopie, vous allez faire, qui va retrouver ces granules au niveau du péritoine et vous faites une biopsie en général pour avoir le diagnostic.

Alors, est-ce qu'il faut réparer les adhérences ? En général non, parce que si on est sur la phase inflammatoire, il faut attendre la guérison. Si vous traumatisez les tissus, ça va encore se recoller encore plus fort, ça risque d'aggraver les lésions. Et puis quand vous avez une tuberculose, je vous ai dit qu'un cas sur deux, vous avez un état de tuberculose à l'intérieur et revenir par la suite pour faire un second look après traitement, bien sûr.

Vous voyez les aspects hystérosopiques, vous voyez qu'on va très mal. L'image hystérosalpingographique qui trouve deux signifi qu'on voit sur l'image à gauche. Deux petits yeux et un pan entre les deux.

Vous coupez le pan, vous libérez la cavité. L'autre aspect, ça vous l'avez dans le cours, les images. Alors l'examen à pâte, bien sûr, chaque fois que vous pouvez le faire, vous le faites, mais ce n'est pas toujours facile.

Vous voyez qu'il a une bonne spécificité mais une mauvaise sensibilité. Et puis vous avez les autres examens, le GeneXpert, l'IDR, vous pouvez faire des prélèvements bactériologiques, une culture, surtout sur le milieu de l'Einstein. Et le plus souvent ces cultures sont longues et elles reviennent négatives.

La PCA, j'en ai parlé, GeneXpert. Et puis les autres examens radiologiques, toujours explorer le poumon. TDM, IRM, parfois vous êtes obligé de la faire parce que si vous partez au départ sur un diagnostic d'une masse annexielle, la hantise, c'est de passer à côté d'un cancer.

C'est pour ça que parfois une TDM ou une IRM est faite, parce que pour vraiment voir si c'est

juste un complexe adhérentiel qui fait un effet de masse, ou bien il y a vraiment une masse tissulaire de l'ovaire. Le spermogramme, il ne faut pas l'oublier parce que quand on est devant un bilan d'infertilité, bien sûr. Et puis il faut savoir que la tuberculose prend plusieurs formes, en fonction bien sûr de l'âge.

On peut avoir des formes très précoces, prépubertaires chez la petite-fille, on peut avoir des formes post-ménopausiques, on peut avoir une tuberculose à tous les niveaux, vagin, col, utérus, comme je vous ai dit, trompe. On peut avoir des formes qui, dites pseudotumorales, c'est là où le diagnostic est généralement difficile, qu'il faut demander une TDM ou une IRM pour caractériser l'effet de masse. On peut avoir des formes aussi aiguës et des formes chroniques.

Des formes chroniques, parfois il y a des tuberculoses qu'on diagnostique 10 ans après. Les patientes ont fait une tuberculose et elles ont été infertiles toute leur vie, elles viennent à la ménopause et on découvre une tuberculose. Ce serait dommage, parce qu'on ne lui a jamais dit que c'est à cause de sa tuberculose qu'elle n'est pas tombée enceinte.

Alors le traitement, je pense que le traitement médical, on vous l'a enseigné, est le plus important. Il faut vraiment refroidir cette tuberculose. Les schémas en général utilisés, on va le voir, mais le but c'est d'abord d'éradiquer les germes.

Comme je vous ai dit, par la suite vous pouvez revenir parce qu'il y a toujours des séquelles et après le traitement des séquelles va être beaucoup plus facile. Sauf que le pronostic il faut le faire avant, parce qu'il ne faut pas promettre des choses à la patiente que vous ne pouvez pas faire. Vous voyez les trompes que je vous ai montrées tout à l'heure, rigides, etc.

On ne peut pas les réparer. Ils sont irréparables. Parce que les destructions, parfois il ne faut pas faire de cellules pour aller réparer des trompes irréparables.

A ce moment-là, on va le voir, il faut passer directement en procréation médicalement assistée. Donc le traitement médical c'est 6 mois. Vous avez le schéma de RHZ et de 4RH, classique, pendant 6 mois.

Et en général, le germe va être éradiqué. Vous avez la posologie sur le tableau que vous avez dans le cours. Alors la chirurgie, il faut la réserver en forme compliquée.

Surtout en secondaire, pas en première intention, en seconde intention, pour réparer les séquelles, pour libérer les adhérences, pour pouvoir faire des placétubères, s'il le faut. Pour pouvoir réparer des sinusitis, réparer un syndrome de Sherman, etc. Mais le plus souvent on va finir en procréation médicalement assistée.

Pour ces infertilités, parce qu'elles vont toucher les trompes d'une façon très agressive et entraîner ce qu'on appelle une stérilité tubaire. Donc quelles sont les indications en général ? Quelle que soit la forme, le traitement médical doit être fait. Pour les abcès, c'est l'association, il

faut vider les abcès, donc il faut drainer l'abcès et le traiter médicalement.

Les pelvis adhérentiels le traitement chirurgical celluloscopique en général en deuxième intention, pas en première intention. Chaque fois que vous avez une infertilité avec une pelvis très adhérentielle après traitement médical ou une impossibilité de réparation tubaire que vous avez sur la radiologie avant d'aller vers une celluloscopie, il faut proposer d'emblée une procréation médicalement assistée type fécondation de vitre. Les sinusites utériles, on les traite beaucoup plus facilement avec l'hystérocopie, sauf pour les syndromes Alzheimer où les sinusites sont très avancées, c'est toujours difficile même avec l'hystérocopie.

Voilà, juste pour finir, pour vous dire qu'en général, infertilité et tuberculose génitales sont le plus souvent associées. Il faut faire le diagnostic pour aller rapidement vers le traitement médical et la chirurgie, il faut les réserver pour les lésions qu'on pourra réparer et en général on va finir par une procréation médicalement assistée. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? La sénéchie c'est une conséquence d'une cicatrisation d'un tissu inflammatoire.

Quand il y a une infection, il y aura de l'inflammation et donc cette inflammation finira par partir et il y aura une fibrose qui va s'installer par la suite. Cette fibrose-là qui accole la face antérieure avec la face postérieure, c'est elle qui va être la sénéchie. C'est l'accolement de la paroi antérieure avec la paroi postérieure.

Lorsqu'il y a un accolement total, c'est le syndrome de la Sherman. Lorsqu'il y a des accolements partiels, c'est la sénéchie. L'infection finit par guérir toute seule et partir vers la chronicité.

Parfois on ne retrouve pas de germes. Sur une tuberculose génitale très ancienne, parfois on ne retrouve pas de germes. On retrouve uniquement des séquelles.

Pas de questions ? Si il n'y a pas de questions, on va voir ensemble la présentation transverse.